

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-02

Toegewezen casus: **C02** (34-jarige administratief medewerker in de zorg)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 25–35 minuten voor de casus (inclusief leestijd instructies en Deel 6)

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als een geautomatiseerd multi-agentsysteem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor uw casus vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap. Aansluitend beantwoordt u in **Deel 6** één algemene reflectievraag over uw digitale benaderingslogica.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand	6
3	Deel 2: Initieel observatiemodel (tweedelig netwerk)	8
4	Deel 3: Behandeldoelprioritering via het tweedelig netwerk	10
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties	12
6	Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)	14
7	Deel 6: Reflectie op digitale benaderingslogica	16
8	Afronding en terugbezorging	18

1 Instructiepagina

Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

PHOENIX (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie**: psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **symptomen** (klacht- en toestandsdimensies die beschrijven wat er mis gaat bij de persoon) en **behandelingsopties** (modificeerbare gedragsvariabelen die de symptomen causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

Kerndefinities: symptoom versus behandelingsoptie

Symptoom (S): een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Symptomen zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. inslaapproblemen, paniekepisoden, sombere stemming). Symptomen zijn geen gedragingen of interventies.

Behandelingsoptie (BO): een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere symptomen en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Behandelingsopties zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging). Een behandelingsoptie is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

- **Symptoom**: inslaapproblemen, anticipatieangst, anergie, piekeren voor het slapengaan.
- **Behandelingsoptie**: avondschermtijd (min), geplande exposurestap (ja/nee), bewegingsfrequentie (min), preslaap-offloading (ja/nee).

Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

EMA is een methode waarbij personen vaak meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel symptomen als behandelingsopties dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar**: via een korte vraag op de smartphone, bijv. (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar**: geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant**: toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid symptoom vs. behandelingsoptie**: klachtdimensies zijn symptomen; modificeerbare gedragingen zijn behandelingsopties.

*De verzamelde EMA-data worden vervolgens ingezet voor **netwerkanalyse**: het kwantitatief in kaart brengen van de empirische verbanden tussen dagelijkse gedragingen (behandelingsopties) en klachtniveaus (symptomen) over meerdere weken. Het resulterende tweedelig netwerk maakt behandelprioriteiten empirisch zichtbaar (zie Deel 3).*

Het tweedelig netwerk: structuur van het observatiemodel

Na voldoende EMA-monitoring construeert PHOENIX een **tweedelig netwerk**: een graaf met twee kolommen sets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Behandelingsopties (BO)**: de modificeerbare variabelen.
- **Rechtse kolom – Symptomen (S)**: de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten**: de richting loopt van behandelingsoptie naar symptoom ($BO \rightarrow S$). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (behandelingsoptie vergroot het symptoom), een *rode* rand op een negatief verband (behandelingsoptie verkleint het symptoom). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de behandelingsopties op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

Overzicht van de vijf taken

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
—	Instructies lezen	Lees de instructiepagina aandachtig door	≈ 5 min
1	Operationalisering	Identificeer 2–6 symptoomlabels (klachtdimensies)	≈ 3 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 behandelingsoptielabels (modificeerbaar, EMA-geschikt)	≈ 3 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik alle 5 behandelingsopties van hoog naar laag behandelprioriteit	≈ 4 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 6 EMA-items (2 per behandel doel) uit de lijst van 20	≈ 4 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 4 min
6	Reflectie digitale aanpak	Beantwoord één algemene reflectievraag over uw EMA-benaderingslogica	≈ 5 min
Totaal (1 casus)			25–35 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 6.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt. Voor Deel 1–5 geldt dit voor de toegewezen casus; Deel 6 is éénmalig.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.

5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.
6. **Werk ook bij beperkte informatie.** Klinische teksten bevatten vaak onvoldoende informatie voor definitieve conclusies. Geef *altijd* een antwoord op basis van de beschikbare informatie en uw klinisch oordeel. Laat geen velden blanco zonder reden.

2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**symptomen**) in de klachtttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort symptoomlabel**.

Wat is een symptoom? Een symptoom is een *klacht- of toestandsdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA),
- op DSM-5-TR/ICD-11-niveau: concreet genoeg om afzonderlijk te meten (bijv. “inslaapmoeilijkheden”, niet het brede “slaapstoornis”), maar niet te atomair (niet “wakker om 3u00” als apart symptoom).

Voorbeelden van goede symptoomlabels: inslaapproblemen, paniekepisoden, anticipatieangst, sombere stemming, emotionele uitputting, anergie, interpersoonlijke instabiliteit, compulsief controleergedrag.

Let op: gedragingen (bijv. “avondschermtijd”), oorzaken (bijv. “werkstress”) en behandelstrategieën zijn *geen* symptomen maar behandelingsopties – die horen in Deel 2.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 symptomen**. Laat ongebruikte velden leeg.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie van wat een correct symptoomlabel is.

Hoe formuleert u een correct symptoomlabel?

Klacht (verkorte versie): *“De afgelopen vijf maanden slaap ik slecht: ik lig lang wakker en word vroeg wakker. Overdag ben ik moe en prikkelbaar. Ik beweeg bijna niet meer en zie vrienden nauwelijks nog.”*

Correct ingevulde symptoomlabels (elk één klachtdimensie, expliciet uit de tekst):

- **S-1** Inslaapmoeilijkheden (*“lig lang wakker” → afzonderlijk meetbaar*)
- **S-2** Vroegochtendontwaak (*“word vroeg wakker” → DSM-5-TR: early morning awakening; onderscheidbaar van S-1*)
- **S-3** Vermoeidheid overdag (*“moe overdag” → toestandsdimensie*)
- **S-4** Prikkelbaarheid (*“prikkelbaar” → emotioneel symptoom, los van S-3*)
- **S-5** Sociale terugtrekking (*“zie vrienden nauwelijks” → klachtpatroon*)

Dit zijn GEEN symptoomlabels (horen in Deel 2 als behandelingsoptie):

- *“Weinig bewegen”* → modificeerbaar gedrag, geen klacht; hoort bij Deel 2.
- *“Slaapproblemen”* → te breed: splits naar meetbare dimensies (zie S-1 en S-2).

Casus 1: 34-jarige administratief medewerker in de zorg

“Ongeveer drie maanden geleden begon ik plots episodes te krijgen waarbij mijn hart tekeergaat, ik het gevoel heb dat ik geen lucht krijg en ik er zeker van ben dat er iets ernstig misloopt. Die episodes zijn heel beangstigend en kunnen zelfs optreden wanneer ik thuis rustig neerzit. Sindsdien ben ik bang geworden om zo’n episode in het openbaar te krijgen en vermijd ik supermarkten, openbaar vervoer en drukke plaatsen. Ik heb mij al meerdere keren ziek gemeld omdat ik bang was dat het op het werk zou gebeuren. Ik weet rationeel dat die situaties niet gevaarlijk zijn, maar de angst blijft overheersen.”

Uw antwoord

[Uw antwoord – Deel 1] **Opdracht:** noteer **2–6 symptoomlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels (2–5 woorden); voeg geen beschrijving toe.

Symptoom 1 Label: _____

Symptoom 2 Label: _____

Symptoom 3 Label: _____

Symptoom 4 Label: _____

Symptoom 5 Label: _____

Symptoom 6 Label: _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel (tweedelig netwerk)

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5** behandelingsoptielabels die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

Wat is een behandelingsoptie in deze context? Een behandelingsoptie is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat de behandelingsoptie de symptomen beïnvloedt.
- **Geen symptoom:** klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* behandelingsopties.

Voorbeelden van goede behandelingsoptielabels: avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging, preslaap-offloading, veiligheidsgedrag, werk-priviegrens, herstelactiviteit, compulsie-uitstel.

Let op: variabelen als “eetlust”, “spierspanning” of “moeheid” zijn klachtdimensies (symptomen) – geen behandelingsopties. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie.

Hoe genereert u behandelingsoptielabels?

Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1 (voorbeeld): S-1: Inslaapmoeilijkheden; S-2: Vroegochtendontwaak; S-3: Vermoeidheid overdag; S-4: Prikkelbaarheid; S-5: Sociale terugtrekking.

Correct ingevulde behandelingsoptielabels:

- **BO-1** Avondschermsgebruik (modificeerbaar gedrag; EMA: minuten voor slapengaan)
- **BO-2** Lichaamsbeweging (modificeerbaar; EMA: minuten actief bewegen per dag)
- **BO-3** Sociaal contact (modificeerbaar; EMA: ja/nee contact gezocht op eigen initiatief)

Dit zijn GEEN behandelingsopties (zijn symptomen, horen in Deel 1):

- “Vermoeidheid” → klachtdimensie (= S-2), geen behandeldoel.
- “Slechte slaap” → klachtdimensie (= S-1), geen behandeldoel.

Casus 1: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 2

34-jarige administratief medewerker in de zorg; duur: 3 maanden. Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.

Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1:

- S-1 Recidiverende paniekepisoden
- S-2 Anticipatieangst
- S-3 Situationele vermijding
- S-4 Beroepsmatige interferentie

Uw antwoord

[Uw antwoord – Deel 2] **Opdracht:** noteer **3–5 behandelingsoptielabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Behandelingsoptie 1 Label: _____

Behandelingsoptie 2 Label: _____

Behandelingsoptie 3 Label: _____

Behandelingsoptie 4 Label: _____

Behandelingsoptie 5 Label: _____

4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het tweedelig netwerk

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 gestandaardiseerde behandelingsopties** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

Wat is een behandeldoel? Een behandeldoel is de behandelingsoptie die, als zij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de symptomen oplevert. Prioriteer op basis van monitoringbewijs (frequentie en ernst van het gedragspatroon), klinische modificeerbaarheid (haalbaarheid voor deze persoon) en netwerkimpact (invloed op meerdere symptomen).

Het tweedelig netwerk lezen:

- Behandelingsopties staan in de **linkerkolom (groen)**; symptomen in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** behandelingsoptie heeft een positief verband met het symptoom (meer van BO → meer van S; bijv. meer veiligheidsgedrag → meer angst).
- **Rode rand:** behandelingsoptie heeft een negatief verband met het symptoom (meer van BO → minder van S; bijv. meer exposure → minder vermijding).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het empirische verband (21-daagse EMA-data).

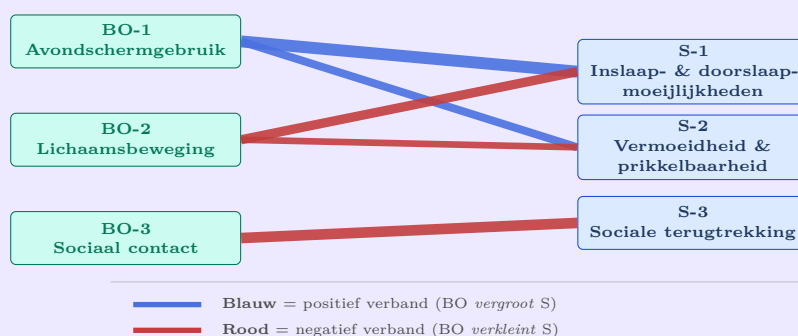
Antwoordformat: vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste prioriteit) tot en met 5 (laagste prioriteit).

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een toelichting op het lezen van het netwerk en de prioriteringslogica.

Hoe leest u het netwerk en rangschikt u de behandelingsopties?

Monitoring (voorbeeld): Schermtijd voor slapengaan: 18/21 avonden actief (gem. 65 min). Lichaamsbeweging: 0,8 sessies/week. Sociaal contact op eigen initiatief: 0,9/week.

Tweedelig netwerk voor dit voorbeeld:



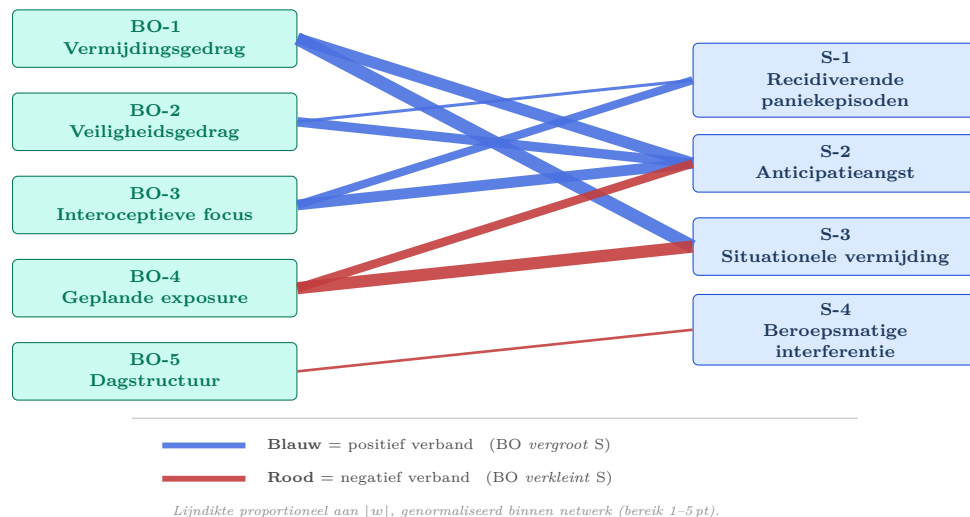
Prioriteringsredenering (voorbeeld):

1. **BO-1 (Avondschermegebruik)** – raakt S-1 en S-2 via sterke blauwe verbanden; monitoring toont 18/21 avonden hoge schermtijd → **prioriteit 1**.
2. **BO-2 (Lichaamsbeweging)** – beschermend effect op S-1 en S-2 (rode verbanden); frequentie extreem laag (0,8/week) → **prioriteit 2**.
3. **BO-3 (Sociaal contact)** – sterk negatief verband met S-3; eveneens laag (0,9/week) → **prioriteit 3**.

Casus 1: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 3

Recidiverende paniekepisoden, anticipatieangst, situationele vermijding en beroepsmatige interferentie.
Duur: 3 maanden.

21-daagse monitoring: Paniekepisoden: gem. 2,3/week. Vermijdingsepisodes: gem. 4,1/dag. Veiligheidsgedrag: gem. 8,7/dag. Geplande exposurepogingen: gem. 0,3/dag. Werkaanwezigheid: 60%. Verwachte angst in publieke settings: 7,8/10.



Uw antwoord

[Uw antwoord – Deel 3] **Opdracht:** rangschik alle 5 behandelingsopties van hoogste naar laagste behandelprioriteit.

Beschikbare behandelingsopties: BO-1: Vermijdingsgedrag, BO-2: Veiligheidsgedrag, BO-3: Interoceptieve focus, BO-4: Geplande exposure, BO-5: Dagstructuur

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-behandelingsopties per behandel-doel** (3 behandeldoelen $\times$ 2 = 6 items).

Wat zijn sub-behandelingsopties? De gestandaardiseerde behandeldoelen in dit deel zijn *abstracte domeinen* (bijv. “Slaapkwaliteit” of “Voedingskwaliteit”). Om dit domein dagelijks via EMA te monitoren, moet het vertaald worden naar *concrete, specifieke gedragsitems* – de **sub-behandelingsopties**.

Hoe werkt de abstracte-naar-concrete vertaling?

- Een abstract behandeldoel beschrijft een *gedragsdomein* (bijv. Slaapkwaliteit, Voedingskwaliteit).
- Een sub-behandelingsoptie is de *concrete gedragsoperationalisering* van dat domein: een specifiek, dagelijks meetbaar item dat het domein direct meet (bijv. “schermvrij interval voor slapengaan (min)” als sub-optie van “Slaapkwaliteit”, of “gezonde maaltijd genuttigd (ja/nee)” als sub-optie van “Voedingskwaliteit”).
- Selecteer per behandeldoel de 2 items die het domein het *meest direct en precies* meten.
- Vermijd items die het domein slechts *zijdelings* raken – zelfs als ze op het eerste zicht verwant lijken.

Belangrijk: alle 20 items in de lijst zijn behandelingsoptie-type EMA-items (modificeerbare gedragingen en strategieën – *geen* symptomen). Uw taak is te selecteren welke 6 items het best aansluiten bij de 3 gestandaardiseerde behandeldoelen, 2 per doel.

Antwoordformat: vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie van de selectielogica.

Hoe selecteert u de meest passende EMA-items per behandeldoel?

Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract, voorbeeld):

1. Slaapkwaliteit
2. Lichamelijke activiteit
3. Sociaal contact

Selectielogica – hoe kiest u de 2 beste items per doel?

Stel: doel 1 = *Slaapkwaliteit*. U ziet de volgende opties in de lijst:

- ✓ “Schermvrij interval direct voor slapengaan (min)” → **juist** (operationaliseert het domein direct)
- ✓ “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)” → **juist** (complementaire meting: regelmaat)
- × “Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)” → **niet juist** (raakt slaap slechts zijdelings, hoort niet bij Slaapkwaliteit)
- × “Maaltijd op vaste tijden genuttigd (ja/nee)” → **niet juist** (hoort bij Voedingskwaliteit, niet bij Slaapkwaliteit)

Correct ingevuld (6 items totaal voor de 3 doelen):

- Doel 1 → “Schermvrij interval voor slapengaan (min)” + “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)”
- Doel 2 → “Duur actieve beweging vandaag (min)” + “Beweegactiviteit uitgevoerd (ja/nee)”
- Doel 3 → “Bewust sociaal contact gezocht vandaag (ja/nee)” + “Sociale activiteit bijgewoond of gepland (ja/nee)”

Casus 1: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract) voor Deel 4:

1. **Exposureopbouw**
2. **Veiligheidsgedragsreductie**
3. **Interoceptieve aandachtsturing**

Uw antwoord

[Uw antwoord – Deel 4] **Opdracht:** selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best aansluiten als sub-behandelingsopties. *Alle 20 items zijn dagelijkse mobiele EMA-items (behandelingsoptie-type, geen symptomen). In het Word-document kunt u de vakjes (□) omcirkelen of markeren in plaats van aanvinken.*

1. ☐ Exposurestap bewust en volledig uitgevoerd vandaag (ja/nee)
2. ☐ Medicatie op voorgeschreven tijdstip ingenomen (ja/nee)
3. ☐ Gebalanceerde maaltijden op vaste tijden genuttigd vandaag (ja/nee)
4. ☐ Duur verblijf in eerder vermeden of angststimulerende situatie (min)
5. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
6. ☐ Omega-3- of vitamine-D-supplement ingenomen (ja/nee)
7. ☐ Veiligheidsgedraging bewust nagelaten bij angstsituatie (ja/nee)
8. ☐ Werkuren vandaag (uren)
9. ☐ Cafeïne-inname na 15.00 uur beperkt (ja/nee)
10. ☐ Aantal veiligheidsgedragingen bewust vermeden of uitgesteld (aantal)
11. ☐ Lichttherapielamp of wekker op licht gebruikt in de ochtend (ja/nee)
12. ☐ Gesprek met vertrouwenspersoon of steunfiguur gevoerd vandaag (ja/nee)
13. ☐ Interoceptieve oefening bewust uitgevoerd vandaag (min)
14. ☐ Sigaretten of tabak gerookt vandaag (aantal)
15. ☐ Financiële zorgen of administratieve taken aangepakt vandaag (ja/nee)
16. ☐ Professioneel consult of therapeutische sessie bijgewoond vandaag (ja/nee)
17. ☐ Lichamelijke sensaties benoemd zonder vlucht- of veiligheidsreactie (ja/nee)
18. ☐ Alcoholconsumptie vanavond (eenheden)
19. ☐ Betekenisvolle of waardegerichte activiteit ondernomen vandaag (ja/nee)
20. ☐ Bewust dankbaarheidsoefening of positieve reflectie uitgevoerd vandaag (ja/nee)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

Theoretisch kader – HAPA: PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

De boodschap voldoet aan:

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een volledige illustratie.

Hoe formuleert u een effectieve coachingsboodschap?

Context (voorbeeld):

- Primair behandeldoel: avondschermggebruik verminderen
- Voornaamste barriere: gewoontekracht – schermgebruik is de enige manier om na het werk te ontspannen (lage zelfeffectiviteit)
- HAPA-fase: intentioneel (wil veranderen, maar heeft nog geen concreet plan)

Voorbeeldboodschap:

“Je weet dat je avondschermd je slaap in de weg staat, maar het voelt nog als de makkelijkste manier om te ontspannen na een drukke dag. Leg vanavond je telefoon om 21.30 uur in een andere kamer en vul die laatste twintig minuten met iets anders – een boek, muziek, of gewoon even niets. Eén avond is genoeg om te merken dat het kan.”

Waarom werkt deze boodschap? De boodschap erkent de barriere (gewoontekracht), geeft een concrete actie met tijdstip (21.30u), verlaagt de drempel (“gewoon even niets”) en vergroot de zelfeffectiviteit (“één avond is genoeg”).

Casus 1: 34-jarige administratief medewerker in de zorg – Deel 5**Primair probleem**

Paniekangst leidt tot toenemende vermijding en duidelijke hinder in het dagelijks functioneren.

Behandeldoel

Geplande exposure aan gevreesde situaties in een hanteerbare, stapsgewijze opbouw.

Voornaamste barriere

Sterke negatieve uitkomstverwachting: de persoon verwacht dat betreden van de situatie onvermijdelijk tot een onbeheersbare paniecreactie zal leiden.

Copingstrategie

Werk met een concrete exposurehierarchie en een vooraf afgesproken copingzin per stap.

Uw antwoord

[Uw antwoord – Deel 5] **Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Deel 6: Reflectie op digitale benaderingslogica

Instructies Deel 6 – Algemene reflectievraag

Context – de PHOENIX-benaderingslogica:

PHOENIX verwerkt een vrije klachttekst via vijf opeenvolgende stappen: (1) identificatie van klacht- en toestandsdimensies als meetbare *symptomen*, (2) generatie van modificeerbare gedragsvariabelen (*behandelingsopties*), (3) prioritering op basis van een tweedelig netwerk dat op dagelijkse EMA-data wordt gefit, (4) selectie van concrete EMA-metitems per behandel doel, en (5) formulering van een gepersonaliseerde dagelijkse coachingsboodschap.

De kern van deze aanpak is **symptoomgedreven netwerkanalyse**: klachten worden niet als uitingen van een vaste stoornis beschouwd, maar als dynamische knooppunten in een netwerk van onderling samenhangende toestandsdimensies. Behandelprioriteiten worden *niet* klinisch verondersteld, maar *empirisch* bepaald op basis van de gemeten verbanden tussen dagelijks gedrag (behandelingsopties) en klachtniveaus (symptomen) over de tijd.

Hypothetische situatie:

Stelt u zich voor dat u als zorgprofessional een vrije klachttekst ontvangt van een persoon met psychische klachten. U beschikt *uitsluitend* over twee middelen:

- een **mobiele applicatie** waarmee de persoon elke dag een korte set vragen beantwoordt (bijv. ja/nee, 0–10 schaal, aantal, minuten) – een EMA-design met dagelijkse datacollectie,
- een **dagelijks digitaal bericht** dat u – of een geautomatiseerd systeem – naar de persoon stuurt (zoals u in Deel 5 formuleerde).

U heeft *geen* directe consulten, telefoongesprekken of andere contactvormen ter beschikking. *Alleen* dagelijkse datacollectie via de app en een dagelijkse geschreven boodschap.

Er is geen enkel correct antwoord. Dit deel dient uitsluitend om uw klinische benaderingslogica in kaart te brengen, zodat die naast die van PHOENIX kan worden geplaatst. Neem voldoende ruimte om uw redenering volledig en concreet te beschrijven.

Reflectievraag a

Welke informatie zou u via de dagelijkse EMA-vragen willen verzamelen, en hoe zou u die selectie bepalen op basis van de vrije klachttekst?

Uw antwoord

[Uw antwoord – Reflectievraag a]

Reflectievraag b

Hoe zou u de dagelijkse boodschappen inhoudelijk afstemmen op wat u via de EMA-data geleidelijk leert over de toestand en het gedrag van de persoon?

Uw antwoord

[Uw antwoord – Reflectievraag b] _____

Reflectievraag c

Zou u uw digitale aanpak systematisch bijsturen naarmate meer data beschikbaar wordt? Zo ja – op basis van welke criteria en via welk redeneerproces?

Uw antwoord

[Uw antwoord – Reflectievraag c] _____

8 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle zes delen voor uw toegewezen casus en de afsluitende reflectievraag.

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 symptoomlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 behandelingsoptielabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 alle 5 behandelingsopties gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Ik heb in Deel 6 de reflectievraag over digitale benaderingslogica beantwoord.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-02

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.